קריטריונים למיון צוללי SCUBA					
נוהל מס'		מהדורה	2	מתאריך	29/02/2014
פרק	רפואה 4	פרק משנה	4.1	עדכון	14/02/2025
רשם	פרופ' פנחס (פיני) הלפרן	מאשר	אדם קונסטנטינובסקי – מנהל הרשות		

<u>הקדמה:</u>

נוהל זה מיועד לרופאי צלילה אולם יכול לשמש כחומר עזר למועמדים לקורס צלילה, למדריכי צלילה ולמנהלי מרכזי צלילה.

הנוהל נכתב במקור ע"י ועדה של מומחים: ד"ר אמיר אברמוביץ ופרופ' אבי שופק, מפקדי מר"י לשעבר, פרופ' יוחאי אדיר, ד"ר משה קוליקובסקי, ד"ר רם ז"ק ופרופ' פיני הלפרן. הוא מתעדכן מדי שנה, באמצעות עדכוני ספרות והתייעצות עם מומחי רפואת צלילה בעלי מומחיות בתחומים שונים.

צלילה ספורטיבית הנה ספורט בטוח ומהנה, המתאים לגילאים צעירים ומבוגרים כאחת. עם זאת, צלילה מתבצעת, מטבעה, בסביבה שהינה זרה לאדם ולכן נחשבת לספורט בסיכון מוגבר. כדי לצלול בבטחה, פותחו לאורך השנים ציוד ונהלים אשר הביאו אותנו למצב הבטיחות הגבוה השורר היום בישראל. שאלת הערכת כושרו הגופני, המנטלי והנפשי של הצולל להתמודד עם המים הנה מורכבת, בעיקר משום שלעתים חסר מידע בדוק מדעית שיסייע לרופאיי הצלילה לקבוע מדדים.

בעולם קיימות גישות שונות למיון רפואי לצלילה ספורטיבית בכלל ולכל מצב רפואי ספציפי בפרט. התורה הישראלית החלה להתפתח בסוף שנות השבעים של המאה הקודמת, על ידי חלוצים כמו ד"ר יהודה מלמד ואחרים ומיושמת בהצלחה מאז. הקריטריונים הרפואיים הנוכחיים למיון רפואי לצלילה ספורטיבית פותחו בשת"פ בין הרופא של הרשות לצלילה ספורטיבית (להלן "הרשות"), מומחי תוכן מהשורה הראשונה וועדת הצלילה של החברה הישראלית לרפואה ופיזיולוגיה הפרברית וצלילה (להלן "החברה").

הגישה העקרונית של המיון הרפואי של צוללים הינה לאפשר לכל אחד ואחת היכולים לצלול בבטחה לעשות זאת.

המטרות המוצהרות של הקריטריונים שלהלן הן:

- לאפשר למי שמבקש לצלול צלילה ספורטיבית לעשות כך, תוך שמירה מקסימלית על בריאותם וביטחונם של הצולל ושל אלה שעמו במים ומחוץ למים.
- לזהות את מי שעלולים לסכן את עצמם או אחרים בצלילה.
- לזהות את מי שזקוקים לסיוע מיוחד בצלילה, להגבלות כגון עומק וסוג הצלילה, או להדרכה ספציפית כדי לצלול בבטחה.

קריטריונים למיון צוללים ספורטיביים

מעודכן לשנת 2025 ע"י פרופ' פיני הלפרן, היועץ הרפואי לרשות לצלילה ספורטיבית

כתובת מייל - hpinny@gmail.com

כללי:

1.1. קריטריונים רפואיים אלה מיועדים כהנחיה כללית לרופא הצלילה ולרופא הצלילה הבכיר, המעריכים כשירות גופנית ונפשית של מועמד לקורס צלילה ספורטיבית SCUBA כהגדרתו בחוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ט-1979 או של צולל ספורטיבי מוסמך שעבר את גיל 45 ו/או צולל שפיתח מצב רפואי משמעותי חדש.

1.2. הקריטריונים מתאימים גם לאישור צולל לצלילת היכרות ספורטיבית חד-פעמית "Intro", Introductory dive.

1.3. הקריטריונים אינם מתאימים לכשעצמם למועמדים לקורסים מתקדמים כגון דייבמאסטר, עוזר מדריך, מדריך, צולל טכני וכד'. בקורסים אלה הדרישות הרפואיות מחמירות יותר ככלל.

1.4. **מסמך זה אינו עוסק ואינו רלוונטי כלשונו לכשירות רפואית לצולל תעסוקתי או מדעי.**

1.5. **לרופא צלילה אין סמכות לחרוג מהקריטריונים הכתובים** ללא אישור רופא צלילה **בכיר** או רופא של רשות הצלילה. רופא צלילה המבקש לשקול כשירות לצלילה של נבדק הסובל ממצב רפואי הפוסל לצלילה לפי מסמך זה, יפנה פיזית או בדואר אלקטרוני, בטלפון או באמצעי תקשורת אחר, לרופא צלילה בכיר או לרופא הרשות. הרופא הבכיר או רופא הרשות יחליטו באם לבדוק את המועמד באורח אישי או אם לקבוע החלטתו על סמך מידע טלפוני, מידע כתוב או אחר. רופא הצלילה יתעד את הייעוץ במסמכי המועמד, כולל את פרטי הרופא הבכיר.

1.6. רופא צלילה בכיר והיועץ הרפואי של הרשות רשאים לחרוג מהקריטריונים לפי שיקול דעתם, תוך הסבר מתועד לסיבת החריגה.

1.7. ההערכה הרפואית ומתן האישור הרפואי לקראת קורס יתבצעו לפני תחילת הקורס, **ובכל מקרה לפני שלב אוויר דחוס**.

1.8. לא יאשר רופא הצלילה בדיקה רפואית על תנאי ולא יחתום על אישור תקינותה, אלא אם כן בדק את כל המסמכים הנחוצים, המעידים גם הם על תקינותה של הבדיקה.

1.9. האישור הרפואי לצלילה יכול להינתן לאחר בדיקה פיזית על ידי רופא הצלילה או רופא הצלילה הבכיר או רופא הרשות, או לאחר קבלת מידע מרחוק עם או בלי שיחה ישירה עם המועמד, הכול על פי שיקול דעת הרופא.

1.10. לאחר אישור הנבדק לצלילה, יעביר רופא הצלילה אישור כשירות לצלילה (ראה נספח בסוף מסמך זה). את טופס הבדיקה עצמו ועליו חוות דעתו ישמור רופא הצלילה בתיוק אצלו למשך 7 שנים לפחות.

1.11. האישור הרפואי לכשירות לצלילה ספורטיבית לא יכלול מידע רפואי חסוי אלא ככל שמידע זה הינו חיוני להגדרת מגבלות או דרישות מיוחדות המוטלות על הצולל ו/או על מרכז הצלילה, וזאת בהסכמת הצולל.

1.12. על הנבדק להציג בפני מרכז הצלילה את אישור הכשירות הרפואית, לפני תחילת קורס הצלילה ולהצהיר בפניו אם חל שינוי כל שהוא במצבו הבריאותי מאז הבדיקה.

1.13. נבדק שנפסל לצלילה, רשאי לערער על כך בפני רופא צלילה בכיר או בפני רופא הרשות. רופא צלילה בכיר רשאי לפנות לרופא הרשות לחוות דעת. רופא הרשות רשאי להתייעץ עם מומחים בתחום הספציפי באם ימצא לנכון, ומשקבע את החלטתו, תהיה זו סופית.

2. <u>הגדרת "רופא צלילה":</u>

2.1. ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) אישרה הכרה ברופאי צלילה כתחום ידע מיוחד, הכפוף לקריטריונים שקבעה המועצה המדעית של הר"י בשנת 2012, ולאישור פרטני של החברה הישראלית לרפואת צלילה ורפואה היפרבארית.

2.2. "**רופא צלילה**" (Diving Physician) הינו רופא שהינו בעל תעודת צולל SCUBA מכל סוג ובוגר קורס רפואת צלילה במכון לרפואה ימית של חיל הים (מר"י) או קורס מקביל אחר כפי שיאשר רופא הרשות יחד יו"ר עם החברה הישראלית לרפואת צלילה ורפואה היפרבארית. רשימה מעודכנת של רופאי צלילה מצויה באתר רשות הצלילה.

2.3. "**רופא צלילה בכיר**" (Senior Diving Physician) הינו רופא בוגר שרות של לפחות שנה במר"י או עבודה של שנה במשרה מלאה במכון רפואת צלילה מקביל בחו"ל ויש לו ניסיון מוגדר בבדיקת צוללים. רשימה של רופאי צלילה בכירים מצויה באתר רשות הצלילה.

2.4. **היועץ הרפואי של הרשות לצלילה ספורטיבית**.

2.5. יועצים מקצועיים כפי שיקבע רופא הרשות.

3. <u>גיל:</u>

3.1. הגיל המזערי לצלילה ספורטיבית הינו 12 שנים.

3.2. הגיל המזערי לצלילת היכרות ("Introductory Dive ("Intro הינו 8 שנים.

3.3. על אף זאת, ישקלו הרופא הבודק והמדריך את כשירותו של מועמד לקורס צלילה ספורטיבית שגילו מעל 12 שנה, והם רשאים לפסול את כשירותו באותו מועד בהתאם להערכתם את כשירותו הפיזית והנפשית.

3.4. כנ"ל יכולים רופא הצלילה או מדריך הצלילה לשקול ולהחליט לגבי מועמד לצלילת הכרות שגילו מעל 8 שנים.

3.5. עד גיל 18 שנה יש צורך גם באישור בכתב ע"י לפחות אחד ההורים או האפוטרופוס החוקי וכן בחתימת אחד ההורים או אפוטרופוס חוקי לפחות על טופס המידע הרפואי שממלא המועמד.

4. <u>כשירות רפואית לקורס צלילה ספורטיבית וחובת בדיקות</u>:

מבצע הבדיקה הרפואית יהיה רופא צלילה כמוגדר לעיל.

4.1. **<u>בני 12-45 שנים: קורס צלילה ספורטיבית בסיסי לרמת כניסה או קורס המשך בצלילה</u>**:

4.1.1. המועמד ימלא טופס היסטוריה רפואית <u>שאושר על ידי הרשות</u>. הטופס החתום יינתן בידי מרכז הצלילה בו עומד להתבצע הקורס. בקטינים עד גיל 18 הטופס ימולא ויחתם ע"י אחד ההורים / אפוטרופוס חוקי.

4.1.2. ככל שכל התשובות בטופס הינן תקינות, הוא יכול להיות מאושר ע"י המנהל המקצועי של מרכז הצלילה.

4.1.3. בכל מקרה של תשובה חיובית, יתייעץ המועמד או המנהל המקצועי של מרכז הצלילה עם רופא צלילה לגבי הכשירות הרפואית של המועמד והצורך בבדיקות או בבירורים נוספים. הייעוץ יתועד בטופס ההיסטוריה הרפואית במרכז הצלילה. **ההתייעצות יכולה להיות גם מרחוק באמצעות טלפון, התכתבות אלקטרונית או אמצעי אחר**, **אך אישור ההשתתפות בקורס חייב להיות בכתב.**

4.2. **<u>בני 45 ומעלה:</u>**

4.2.1. עצם הגעתו של צולל **מוסמך** לגיל 45 **אינה** מחייבת ביצוע בדיקות רפואיות, למעט אם חל שינוי מהותי במצבו הרפואי של הצולל.

4.2.2. **קורס בסיסי**: מי שהגיע לגיל 45 ומבקש לעבור **קורס** צלילה ספורטיבית בסיסי, יעבור בדיקות כמפורט בסעיף 4.2.4 להלן.

4.2.3. **קורסי המשך לצולל מוסמך**: צולל מוסמך בכל דרגה, שהגיע לגיל 45 ומבקש לבצע קורס המשך מתקדם כאשר ההתמחות או ההכשרה הכוללת תוספת עומק לזה הקיים ברישיונו עד כה, כולל קורסים טכניים המעניקים טווח דקומפרסיה, התמחות עומק, התמחות הצלה, **יעבור בדיקת רופא צלילה**, כמפורט בסעיף 4.2.3 להלן.

4.2.4. צוללים בני 45 ומעלה המבקשים לעבור כל קורס, בין אם קורס בסיסי או קורס המשך, יעברו בדיקה פיזית **אצל רופא צלילה**, הכוללת לפחות:

4.2.4.1. אנמנזה רלוונטית מלאה ובדיקה גופנית.

4.2.4.2. אק"ג במנוחה.

4.2.4.3. אק"ג במאמץ ו/או אקו לב במאמץ.

4.2.4.4. **רופא הצלילה רשאי לדרוש ביצוע בדיקות נוספות**.

4.2.5. בדיקת כשירות רפואית שבוצעה עקב גיל הצולל **תקפה למשך 5 שנים** מהוצאת האישור הרפואי, ככל שזה נוגע לצורך בבדיקה לקראת עוד קורס.

4.3. **<u>בכל הגילים – בדיקה רפואית עקב שינוי מהותי במצבו הבריאותי של צולל מוסמך</u>**:

4.3.1. צולל מוסמך שחווה אירוע רפואי או התגלתה אצלו מחלה חדשה, שעלולים לדעת רופאיו או שאמורים להבנת צולל סביר לפגוע בכושר הצלילה שלו או בבטיחות הצלילה, יפנה לקבל אישור רפואי **מרופא צלילה** קודם שישוב לצלול לאחר האירוע.

4.3.2. ככל שהצולל חווה **תאונת צלילה**, חזרתו לצלילה דורשת בדיקה כנ"ל אך על ידי **רופא צלילה בכיר**.

4.4. **<u>תיירים</u>**: תייר (בכל גיל) מחויב במילוי **שאלון רפואי בלבד**. האחריות על כשירותו הרפואית מוטלת על התייר עצמו בלבד. עם זאת, למנהל המקצועי של המועדון שמורה הזכות, ככל שנודע לו מצב רפואי שנראה מסוכן בצלילה או שהוא מתרשם מבעיה רפואית או תפקודית, לדרוש מהתייר לקבל אישור מרופא צלילה ישראלי.

4.5. **<u>שאלון הבריאות</u>**: הטופס ימולא זמן סביר קודם הקורס, על מנת להשאיר זמן לבירורים רפואיים נדרשים. מדריך צלילה מוסמך או רופא צלילה ינחה את המועמדים לגבי מילוי השאלון קודם מילוי הטופס.

מרכז הצלילה ידגיש בפני מועמד את ההנחיות הבאות:

4.5.1. השאלון מהווה למעשה את הכלי היחיד לבדיקת כשירות רפואית של רוב המועמדים, ולכן חיוני למלא את השאלון הרפואי בקפדנות ותוך אמירת האמת.

4.5.2. מועמד לקורס או צולל מוסמך **שגילו מעל 45**, יציג בפני מרכז הצלילה אישור של רופא צלילה שעמד בקריטריונים הרלוונטיים לצולל בגילו.

4.5.3. למועמד מומלץ להתייעץ עם מדריך הצלילה או עם רופא צלילה בכל מקרה של ספק בתשובה הנכונה לשאלה כלשהי בשאלון.

4.5.4. מועמד לצלילה **שגילו פחות מ 45**, שענה **בשלילה** על כל שאלה בשאלון, סיים את ההערכה הרפואית והוא **כשיר** רפואית להתחיל בקורס הצלילה.

4.5.5. מועמד לצלילה **שגילו פחות מ 45**, אשר ענה **בחיוב** לאחת מהשאלות, יופנה לרופא צלילה. **רופא צלילה** (ולא רופא אחר, גם אם מומחה) יעריך את משמעות התשובה החיובית. ההערכה יכולה להתבצע בבדיקה פיזית של המועמד, בשיחת טלפון או בתקשורת אלקטרונית אחרת עם המועמד, בעיון בחומר כתוב שהמועמד יעביר לרופא, הכול לפי שיקול דעתו של רופא הצלילה.

4.5.6. קבע רופא הצלילה כי הממצא איננו פוסל לצלילה, גם בלא צורך בבדיקה גופנית או בבדיקות עזר, ירשום ממצאיו בטופס אישור כשירות אותו יעביר לצולל או למועדון בדואר אלקטרוני או בפקס או באמצעי אחר, ויאשר את המועמד. עותק של האישור הכתוב ישמר אצל הרופא כמו כל מסמך רפואי בהתאם לחוקים ולנהלים.

4.5.7. אם נדרשת בדיקה גופנית ו/או בדיקות עזר או יעוץ מומחים, יפסל המועמד זמנית ויונחה לפנות למרפאה מתאימה, **אשר איננה בחצרי מועדון הצלילה**.

4.5.8. מצא רופא הצלילה, כי הממצא או הפרט האנמנסטי אינם מאפשרים לו להחליט על דעת עצמו, יפנה טלפונית או בדוא"ל או באמצעי אחר לרופא צלילה בכיר או ליועץ הרפואי של הרשות. תוצאת ההתייעצות תתועד על ידו בטופס הבדיקה והודעה על פסילה תועבר כאמור לעיל.

4.5.9. החלטתו של רופא הרשות תהייה סופית.

5. <u>מצבים מיוחדים:</u>

5.1. **כשירות רפואית לאחר תאונת צלילה** שדרשה טיפול בתא הלחץ, או גרמה לנזק גופני משמעותי (למשל בארוטראומה) או שהתבטאה באירוע לבבי הקשור לכאורה לצלילה וכד', תחודש רק ע"י **רופא צלילה בכיר** או רופא הרשות. עד אז, הצולל בלתי כשיר רפואית לצלול. חבלת לחץ באוזן תיכונה או במערות הפנים אינה כלולה בסעיף זה וכל רופא (לאו דווקא רופא צלילה) רשאי לקבוע שהיא החלימה והצולל כשיר מבחינה זאת (בלבד) לחזור לצלילה.

5.2. **אנשים עם מוגבלות פיזית, נפשית, קוגניטיבית או מנטלית**: כשירותם הרפואית תינתן ע"י **רופא צלילה בכיר** או על ידי **רופא הרשות**.

5.3. **פציעות ומחלות**: לאחר כל פציעה, מחלה או אשפוז שאינם תאונת צלילה שדרשה טיפול בתא לחץ, על הצולל לקבל אישור חזרה לצלילה מ**רופא צלילה.** רופא הצלילה רשאי להתייעץ עם רופא צלילה בכיר על פי שיקול דעתו.

5.4. **חומרים פסיכואקטיביים**: יודגש, כי צלילה תחת השפעת אלכוהול או חומרים פסיכואקטיביים אחרים (כגון קנאביס), למעט תרופות (שאינן קנאביס) שהצולל נוטל באורח קבוע לפחות חצי שנה בהוראת רופא, הינה מסוכנת ואסורה. ככל שהתרופות הפסיכואקטיביות ניטלות עקב מצב נפשי או מנטלי הדורש אישור רפואי, יפעל הצולל בהתאם לקריטריון הרלוונטי להלן.

5.5. **צלילת הכרות**:

5.5.1. צלילת הכרות\אינטרו Introductory dive נערכת בתנאים מבוקרים ותחת השגחה אישית קפדנית, בהתאם לחקיקה ולנוהל המפורסם.

5.5.2. הואיל וכך, הקריטריונים הרפואיים הינם פשוטים יותר וכוללים אנמנזה בלבד, עם התייחסות רופא צלילה לממצאים חיוביים באנמנזה וכן הערכה תפקודית בלבד של המדריך.

5.5.3. כשירות רפואית לצלילת אינטרו כוללת:

5.5.3.1. מילוי טופס שאלון רפואי כמופיע בחוק ובתקנות הצלילה הספורטיבית.

5.5.3.2. ככל שהתשובות בטופס האנמנזה תקינות כולן – אין צורך בבירור רפואי נוסף.

5.5.3.3. כל תשובה חיובית מחייבת אישור רופא צלילה.

5.5.3.4. אישור רופא צלילה כזה יכול להינתן בטלפון, במייל או באמצעי תקשורת אלקטרונית אחר.

5.5.3.5. המדריך במרכז הצלילה ירשום בטופס המידע הרפואי של הצולל את שמו של רופא הצלילה, את מספר הטלפון הנייד שלו ו/או הדוא"ל, ומתי הרופא אישר לצולל לבצע את הצלילה.

מערכת העצבים המרכזית:

פסילה תמידית:

1. כל מחלה היכולה להביא לאובדן ההכרה או להגבלה תפקודית פתאומית חולפת או קבועה.
2. **התכווציות** (convulsions) במהלך 5-3 השנים האחרונות. חולה אפילפסיה ראשונית, או מי שלקה בפרכוסים לאחר חבלה או ניתוח מוח או אירוע מוחי, אשר אינו מקבל טיפול זה 5-3 שנים, מציג EEG תקין מעודכן וחוות דעת חיובית מנוירולוג וחופשי מהתקפים – כשיר.
3. מיגרנה הגורמת להפרעות תפקודיות או המלווה בהפרעות בתרשים גלי המוח (EEG).
4. כל חסר נוירולוגי קבוע הגורם להפרעה תפקודית (כגון: neurosyphylis, CNS poliomyelitis tumors, demyelinating diseases וכד') אשר לדעת רופא הצלילה או מדריך הצלילה פוגע בבטיחות הצלילה של הצולל או של בני זוגו. **לשיקול דעת רופא צלילה בכיר או רופא הרשות**.
5. פגיעה ישירה ברקמת המוח או בחוט השדרה, כולל בניתוח, עם שאריות נוירולוגיות - **לשיקול דעת רופא צלילה בכיר או רופא הרשות**.
6. פגיעה מוחית מולדת כגון שיתוק מוחין, תסמונת PDD, ADD, אספרגר ואחרות עם פגיעה תפקודית משמעותית: **לשיקול דעת רופא צלילה בכיר או רופא הרשות**. לפי שיקול דעתו, הרופא יתייעץ עם מדריך צלילה המנוסה בהדרכת צוללים עם פגיעות כאלה.
7. תסמונת **ADHD** Attention Deficit [Hyperactivity] Disorder – לאישור רופא צלילה, הרשאי לפי שיקול דעתו להתייעץ עם רופא צלילה בכיר.

פסילה זמנית:

1. אירוע מוחי (דימום תוך מוחי או אירוע איסכמי), דימום אפידוראלי או תת דוראלי או תת עכבישי וכד', ניתוח מוח, חבלה מוחית, לפחות 6 חודשים או עד החלמה מלאה או למצב של נזק שיורי שאינו מפריע תפקודית לצלילה. בכל מקרה – ללא פרכוסים או טיפול נוגד פרכוסים.
2. שבר בבסיס הגולגולת עם rhinorrhea או otorrhea: עד שנה לאחר החלמה מלאה.
3. זעזוע מוח (brain concussion) ואובדן הכרה למשך פחות מ- 24 שעות: פסילה למשך שלושה חודשים לפחות, ועד לאחר החלמה מלאה הכוללת בדיקה נוירולוגית קלינית ותרשים EEG תקינים.
4. Transient Ischemic Attack (TIA): פסילה למשך 3 חודשים אם הייתה סיבה הפיכה (טיפול בגלולות, למשל) ולא נמצא גורם סיכון בלתי ניתן לטיפול (חסימה חמורה של עורק תרדמה, למשל או מפרצת מוחית.
5. סיפור של איבוד הכרה ליותר מ- 24 שעות מכל סיבה פוסל לשלושה חודשים ומחייב חוות דעת נוירולוג או נוירוכירורג מומחה.
6. מחלה זיהומית של מערכת העצבים המרכזית (מנינגיטיס חיידקית, מורסה מוחית וכד') עד להחלמה מלאה, ובתנאי שבדיקה נוירולוגית ו- EEG הנם תקינים.
7. אירועי syncope מכל סיבה למעט סינקופה בגיל צעיר וללא מאפייני סיכון - **להכרעת רופא צלילה בכיר או רופא של הרשות**.

מחלות נפש ואתגרים נפשיים/מנטליים:

כללי:
הקריטריונים המפורטים להלן הינם **זמניים ומעודכנים מעת לעת**. הרשות כבר מאשרת לצלילה, בזהירות הראויה, אנשים המתמודדים נפשית או מנטלית. האישור הינו אישי לגבי כל מועמד.

תהליך הבדיקה הרפואית לקבלת כשירות למועמד המתמודד עם אתגר נפשי או מנטלי, למעט תסמונת בתר-חבלתית PTSD:

1. המועמד רשאי לפנות ישירות לרופא צלילה בכיר או לרופא הרשות. הפניה תלווה בטופס מיון מקדים המופיע בנספח להלן.
2. לחלופין, המועמד רשאי להיבדק תחילה אצל רופא צלילה. הפניה תלווה בטופס מיון מקדים המופיע בנספח להלן.
3. ככל שרופא הצלילה החליט כי המועמד **אינו כשיר**, המועמד רשאי לפנות להתייעצות אצל רופא צלילה בכיר או רופא הרשות.
4. ככל שרופא הצלילה החליט כי המועמד יכול - על פניו - **להיות כשיר**, יפנה אותו עם הסבר כתוב לרופא הרשות פרופ' הלפרן בדוא"ל hpinny@gmail.com

פסילה:

1. מאותגר נפש או מנטלי המוגבל משמעותית מתבחינה תפקודית ו/או נוטל תרופות מרובות ו/או שינה את מינון ו/או סוג התרופות לפני פחות משישה חודשים, או הסובל מתופעות לוואי קשות של הטיפול התרופתי.
2. פסיכוזה כרונית פעילה, דיכאון אנדוגני קשה, מצבים מאניים או דיכאוניים, עם הפרעה תפקודית משמעותית.
3. קלוסטרופוביה קשה עם הפרעות תפקודיות.
4. אלכוהוליזם עם הפרעות תפקודיות משמעותיות או מחלות אורגניות שנגרמו בעקבותיו.
5. התמכרות פעילה לסמים קשים, כולל קנאביס.
6. הפרעות חרדה עם הפרעות תפקודיות ניכרות.
7. תסמונת בתר חבלתית עם הפרעות תפקודיות ניכרות.

דיון פרטני אצל רופא הרשות ובמידת הצורך ביעוץ מומחים:

1. פסיכוזה טוקסית או שלאחר לידה, עד 6 חודשים לאחר החלמה מלאה.
2. אירוע פסיכוטי בודד שחלף, ברמיסיה ועם תפקוד שמור, להחלטת רופא צלילה בכיר או רופא הרשות.
3. פסיכוזה קלה ברמיסיה זה 6 חודשים לפחות, ללא טיפול תרופתי או עם טיפול תרופתי שרופא צלילה בכיר מאשר, ללא הפרעות תפקודיות ניכרות.
4. כל שאר המצבים – בהתאם לנוהל שתוציא הרשות בבוא העת. עד אז, יפנה המועמד לרופא צלילה להערכה ראשונית והלה יפנה אותו לפי שיקול דעתו לרופא הרשות להערכה פרטנית.

תסמונת בתר-חבלתית PTSD:

1. לאחר מאורעות 7/10/2023 ופרוץ המלחמה, גבר מאוד זרם המועמדים המזוהים כלוקים ב PTSD ומבקשים לצלול.
2. רבים מהמאובחנים ב PTSD אינם לוקים בסימפטומים או בחומרה הרלוונטיים לצלילה. עבור מועמדים אלו, רופא צלילה רגיל יהיה רשאי לאשר מועמד המתפקד תפקוד אישי וחברתי מלא. ככל שנמצאה הפרעה תפקודית, יש להפעיל נוהל מאותגרי נפש דלעיל. רופא הצלילה רשאי להתייעץ עם רופא צלילה בכיר או עם רופא הרשות.

צלילה תחת השפעת קנאביס

1. השימוש הלא רפואי בקנאביס בישראל אינו חוקי. הוא מוגדר כסם מסוכן תחת חוק הסמים המסוכנים ואסור לשימוש במדינת ישראל. עם זאת, השימוש הרפואי בקנאביס למטרות רפואיות הינו חוקי.
2. קנאביס המכיל מגוון גדול של חומרים פעילים. הרלוונטי לנושא הצלילה הוא בעיקר ריכוז וכמות החומר הפסיכו-אקטיבי העיקרי בקנאביס – THC=Tetra Hydro Cannabinol.
3. נכון להיום, אין דרך מעשית או בסיס חוקי לבדוק אם אדם נמצא ברגע נתון תחת השפעת קנאביס.
4. ההשפעה הפסיכו-אקטיבית של קנאביס כוללת בין השאר: ירידה ביכולת מעקב, ערות, קואורדינציה בין היד לעין, קבלת החלטות, הערכת מרחקים ויכולת ריכוז. כל אלה עלולים לפגום בבטיחות הצולל במהלך הצלילה. עם זאת , אין עדיין מידע סטטיסטי ממוקד לגבי הסיכון הכרוך בצלילה תחת השפעת קנאביס בכלל ו THC בפרט.
5. משך פעולת הקנאביס תלוי בצורת הלקיחה (עישון או נטילה דרך הפה), בחילוף החומרים האישי ועוד. לא ניתן לנבא במשתמש הספציפי כמה זמן משימוש לוקח עד שרמת THC בדם יורדת מתחת לסף הפסיכו-אקטיבי, מה עוד שסף זה אינו מוגדר.

הנחיה: למעט בשימוש במוצר שהינו נטול THC לחלוטין, לא יצלול אדם בטווח של:

- שמונה שעות מהשימוש האחרון בקנאביס בבליעה (תמצית, שמן, מיצוי, טינקטורה).
- ארבע שעות מהשימוש האחרון בקנאביס בעישון או באידוי או בספריי.

מקורות מידע:

דף המידע של ארגון DAN מ 2019 בנושא קנאביס וצלילה: לינק . ציטוט המלצתם:

Since the psychoactive effects are the main acute safety concern during diving, and everyone responds differently to the consumption of cannabis, ***it is advisable that divers stay out of the water for at least eight hours following smoking or ingestion*** *of cannabis cookies or the oil (in case the oil has any THC) to be confident there will be no psychoactive effects.*

- הרצאה ודיון בנושא קנאביס וצלילה לינק
- הספר הירוק של משרד הבריאות – לינק

מערכת קרדיווסקולרית:

פסילה תמידית:

1. מחלת לב המגבילה את מצבו של הנבדק לעמוד במאמצים גופניים משמעותיים, או העלולה לגרום לאיבוד הכרה או לאיבוד כושר תפקוד באופן פתאומי ובלתי צפוי.
2. מחלת לב איסכמית או מצב לאחר אוטם שריר הלב, למעט אם התקיימו כל התנאים הבאים:
   א. בדיקת אק"ג או אקו במאמץ או מיפוי לב במאמץ, תקינה לאחר השגת דופק מטרה.
   ב. אקו לב או מיפוי או צנתור, המראה תפקוד תקין או ירידת תפקוד מינימאלית של המיוקרדיום.
   ג. מיפוי SPECT או אקו לב במאמץ שאינו מראה איסכמיה הפיכה.
   ד. הצולל אסימפטומטי מבחינה לבבית (אינו סובל מכאבים בחזה או מקוצר נשימה, גם במאמץ).
   ה. הצולל הציג חוות דעת עדכנית של קרדיולוג מומחה, המאשרת הנ"ל.
   ו. רופא הצלילה רשאי לדרוש חוות דעת חוזרת של קרדיולוג כנ"ל, מדי שנה עד שנתיים.
3. מומי לב מולדים, גם שתוקנו כירורגית, (כגון מומים במחיצות הלב, דוקטוס ארטריוזוס, PDA, דלף עורקי ורידי ריאתי, הצרות אבי העורקים), עם אקו לב תקין ויכולת מאמץ תקינה – להחלטת רופא צלילה בכיר או רופא הרשות.
4. מחלת לב מסתמית או מיוקרדיאלית הגורמת להפרעות קליניות ו/או המודינמיות, בעיקר אם עלולה להיות מוחמרת בעצירת נשימה ו/או פעולת Valsalva. מחלה מסתמית אסימפטומטית, עם תפקוד לב תקין – אינה פוסלת, אך נדרש אישור מחודש של קרדיולוג מדי שנתיים, לפי החלטת רופא הצלילה.
5. צניחת מסתם מיטרלי סימפטומטית. ניתן לאשר נבדקים ללא כל סיפור של הפרעות קצב או הפרעות תפקודיות, וארגומטריה ואקוקרדיוגרפיה תקינים. אקו לב כל שנתיים חובה.
6. קוצב לב: ניתן לאשר אם מתקיימים **כל** התנאים הבאים:
   א. תפקוד מיוקרדיום תקין.
   ב. הקוצב תקין.
   ג. אין מחלה כלילית פוסלת.
   ד. הקוצב אושר רשמית ובכתב על ידי היצרן, לצלילה עד עומק נתון.
   ה. אישור רופא צלילה בכיר או רופא הרשות.
7. מצב לאחר ניתוח לב מכל סוג או קרדיומיופטיה מכל סוג: לאישור רופא צלילה בכיר או רופא הרשות. הערכה תפקודית תכלול לפחות מבחן מאמץ ואקו לב.
8. מחלת כלי דם היקפיים (PVD) המגבילה תפקודית (גם לאחר טיפול כירורגי או אנדו-ווסקולרי מוצלח) ו/או מלווה בפגיעה ווסקולרית באברי מטרה אחרים. נבדקים ללא עדות לפגיעה כזאת, לאישור רופא צלילה בכיר או רופא הרשות.
9. מצב לאחר מאורע טרומבוטי או תסחיפי עורקי או ורידי – עד 3 חודשים אחרי האירוע, ובתנאי שאין הפרעה תפקודית משמעותית.
10. אק"ג פתולוגי, כגון חסמים גבוהים בצרור AV, מחלת ברוגדה, מקטע QT מארך משמעותית וכד', אך למעט:

א. חסם ידוע בצרור ההולכה הימני (ICRBBB) בנבדקים צעירים אסימפטומטיים.
ב. חסם ידוע בצרור ההולכה השמאלי ICLBBB ללא הפרעה תפקודית במפורט בסעיף 6 לעיל.
ג. חסם פרוזדורי חדרי מדרגה ראשונה (1ST degree AVB) ללא עדות קלינית למחלת לב ואקוקרדיוגרפיה תקינה.
ד. סינוס אריטמיה ללא סיבה מטבולית או אחרת הפוסלת לכשעצמה.
ה. פעימות מוקדמות הנעלמות במאמץ.
ו. תסמונת Wolf Parkinson White – במצב קל ללא סימפטומים המפריעים תפקודית, או לאחר טיפול אלקטרו פיזיולוגי מוצלח. אישור קרדיולוג חובה וכן אישור חוזר מדי שנתיים.

11. הפרעות קצב מהירות או איטיות (tachyarrhythmia או Bradyarrhythmia), עם סיפור של איבוד הכרה או הפרעה תפקודית משמעותית בעת האירוע. מקרים אסימפטומטיים מחייבים בדיקת אקו לב ומאמץ ואישור קרדיולוג ורופא צלילה בכיר.
12. מצב של יתר לחץ דם עורקי לא מאוזן ו/או מלווה בפגיעה משמעותית באברי מטרה, באישור רופא צלילה בכיר. טיפול בחוסמי רצפטור ביטא וחוסמי תעלות סידן אינו פוסל אם אין עדות קלינית, אנמסטית או אקוקרדיוגרפית לפגיעה לבבית תפקודית.

<u>פסילה זמנית:</u>

1. פקקת ורידים עמוקה: להחלטת רופא צלילה בכיר או רופא של הרשות 6 חודשים לאחר החלמה מלאה וללא סיפור של תסחיף לריאות.
2. כושר גופני לקוי מאד: מבחן Ruffier עם ציון הגבוה מ- 15, עד לשיפור הכושר הגופני. מבחן Ruffier כולל מדידת דופק בסיסית P_0, ביצוע 30 כפיפות ברכיים מעמידה לכריעה שלמה עם כפות רגליים שטוחות על הרצפה וללא משענת, מדידת דופק חוזרת 60 שניות P_1 ו- 120 שניות P_2 לאחר הכפיפות, תוך המבדק וחישוב לפי הנוסחה:

$$\textbf{Index} = [(P_0+P_1+P_2)-200/10$$

במבחן זה נחשב ציון 0 למצוין, עד 5 לטוב מאד, עד 10 לטוב, עד 15 לממוצע, מעל 15 לגרוע.

3. מצב לאחר myocarditis, pericarditis או SBE , לאישור רופא צלילה בכיר או רופא הרשות.

מערכת הנשימה ובית החזה:

פסילה תמידית:

1. עיוות צורת בית החזה הגורם להפרעות משמעותיות בתפקודי הריאות. לאחר ניתוח לתיקון – להחלטת רופא צלילה בכיר או רופא הרשות.
2. מצב אחר ניתוח בבית החזה או חבלה לבית החזה, עם פתיחת הפלוירה, למעט אם בדיקת CT של בית החזה ברזולוציה גבוהה אינה מראה פתולוגיה משמעותית בפרנכימת הריאות או הצטלקות פלוירלית נרחבת.
3. מצב לאחר חזה אוויר עצמוני (ספונטני) או מיצד אוויר עצמוני (Pneumomediastinum).
4. מחלות ריאה כרוניות כגון:
   א. כל מחלה גרנולומטוטית (שחפת, פטריות, סרקואידוזיס וכו'), גם לאחר החלמה, למעט אם בדיקת CT ברזולוציה גבוהה אינה מראה פתולוגיה משמעותית בפרנכימת הריאות ו/או הצטלקות פלוירלית נרחבת.
   ב. pneumoconiosis או לייפת הריאות (pulmonary fibrosis).
   ג. נפחת הריאות (emphysema).
   ד. ברונכיאקטזיות.
   ה. ברונכיטיס כרונית.
   ו. אסטמה כרונית פעילה.
5. גנחת הסימפונות (אסטמה):
   א. ניתן לאשר צולל שלקה בעברו באסטמה או ברונכיטיס ספסטית, שהנו אסימפטומטי ולא נזקק לכל טיפול מרחיב סימפונות כלל (טיפולי או מונע) משך שלוש שנים לפחות.
   ב. אישור החולה האסימפטומטי מחייב תפקודי ריאות תקינים, כולל מבחן מאמץ ו/או מבחן מטאכולין methacholine.
6. מצב לאחר תסחיף לריאות (pulmonary thromboembolism): להערכת רופא צלילה בכיר או רופא הרשות, עם תפקודי ריאות מלאים כולל הערכת תקינות דיפוזיה (DLCO) והוכחת לחץ תקין בעורק הריאה (בדופלר אקו או צנתור) ועם חוות דעת המטולוג.
7. הממצאים הבאים בצילום רנטגן או בבדיקת CT של בית החזה פוסלים לצלילה: מורסה, cavity, ציסטה, bulla, תהליך תופס מקום, גוף זר בסימפון - שאינו ניתן לסילוק ברונכוסקופי, הידבקויות פלוירליות נרחבות, תמט קבוע של אזור ריאה (atelectasis), primary complex הגדול מ- 1 ס"מ או קשרי לימפה מסוידים או מוגדלים בשער הריאה, לבד אם בדיקת CT של בית החזה אינה מראה לחץ על סימפון או עיוות פרנכימטי משמעותי

פסילה זמנית:

1. זיהום בדרכי הנשימה העליונות עד להחלמה מלאה.
2. דלקת ריאות או דלקת של קרום הריאה עד חודש לאחר החלמה, בתנאי שצילום בית החזה תקין.

מערכת השלד והשרירים:

פסילה תמידית:

1. עקמת קשה הגורמת להפרעות בתפקודי הריאות, למעט אם תוקנה כירורגית.
2. נמק עצם אווסקולרי (Avascular Bone Necrosis) שעקב צלילה.
3. מחלת שרירים כרונית, הפוגעת מהותית בתפקוד המוטורי ובעיקר בתפקוד שרירי הנשימה. תפקודי נשימה מלאים כולל maximal negative pressure and maximal voluntary ventilation חובה. מחלות ניווניות, דיסטרופיות, מיאסטניה גראוויס: לאישור רופא צלילה בכיר או רופא הרשות ובתנאי שתפקודי ראות, כולל במאמץ סביר, הינם תקינים.

פסילה זמנית:

1. שבר בעצם גדולה עד לאיחוי רנטגני מלא.
2. כאב גב תחתון הגורם להגבלה בתנועה – עד להחלמה.

הערה: משתלים גרמיים אינם פוסלים לצלילה.

עיניים:

פסילה זמנית:

1. דלקת חריפה של העין או הלחמית או העפעפיים.
2. מצב לאחר ניתוח עיניים:
   א. הסרת ירוד (cataract) בשיטת פאקו שלושה חודשים לאחר הניתוח.
   ב. הוצאת ירוד בשיטה אחרת – שישה חודשים.
   ג. ניתוח עקב טראומה לעין – שישה חודשים לאחר ניתוח שיקום העין האחרון.
   ד. השתלת קרנית – שישה חודשים לאחר הוצאת תפר אחרון.
   ה. בכל מקרה נדרש אישור רופא עיניים.
3. דלקת כרונית או פעילה של העין כגון: uveitis, iritis, iridocyclitis, choroiditis, chorioretintis כשיר לאחר שישה חודשים אסימפטומטיים.
4. ניתוחי קרנית לתיקון חדות ראייה:
   א. ניתוח LASIK: כשיר לאחר חודש מהניתוח ובתנאי שיש בדיקה תקינה של רופא עיניים.
   ב. ניתוח RK: כשיר לאחר 6 חודשים מהניתוח ובתנאי שיש בדיקה תקינה של רופא עיניים.
5. הפרדות רשתית לאחר תיקון: כשיר 6 חודשים לאחר ניתוח או שלושה חודשים לאחר תיקון באמצעות לייזר בלבד ובדיקה תקינה של רופא עיניים.
6. גלאוקומה לאחר ניתוח סינוני: כשיר שישה חודשים מהניתוח ובדיקה תקינה של רופא עיניים. גלאוקומה המאוזנת בתרופות בלבד אינה מגבילה לצלילה.
7. קוצר ראיה גבוה: **קוצר ראיה מעל 6 דיופטריות דורש בדיקת קרקעית העין ע"י רופא עיניים** ואישורו שהרשתית תקינה.

שיקולים נוספים:

1. מצב לאחר enucleation עם orbital implant, יש לוודא שהשתל אינו חלול.

מערכת העיכול

פסילה זמנית:

1. מחלות הוושט:

א. מחלות וושט המאופיינות בהקאות חוזרות (למשל Reflux חמור, Achalasia., דיברטיקולום ע"ש Zenker וכו') פוסלות עד לטיפול מוצלח.

ב. Para esophageal hernia - עד לתיקון כירורגי.

2. מחלה פפטית: מחלה פפטית עם סימפטומים קשים או סיבוכים עד לטיפול מוצלח.
3. Inflammatory Bowel Disease: IBD (כגון: מחלת Crohn, Ulcerative Colitis) פסילה זמנית בזמן התקף חריף.
4. מחלות חריפות של דרכי העיכול.
5. מצב לאחר ניתוח בטן (laparotomy) עד 3 חודשים לאחר החלמה מלאה וללא בקע בקדמת הבטן.

פסילה תמידית:

שחמת הכבד עם יתר לחץ דם בוריד השער מכל סיבה.

סטומה stoma ממערכת העיכול: סטומה שאינה continent כלומר מתרוקנת ללא ספינכטר או שסתום, אינה מהווה הוריית נגד לצלילה. על רופא הצלילה להנחות את הצולל כיצד להתנהל נכון בצלילה. סטומה קונטיננטית דורשת אישור של רופא צלילה בכיר לאחר שעיין בסיכום הניתוח ורצוי שיתייעץ עם הכירורג המנתח או כירורג העוסק בתחום זה.

דרכי השתן והמין:

פסילה זמנית:

1. גלומרולונפריטיס, פיילונפריטיס, עד החלמה מלאה.
2. סיפור של הפרעות במתן השתן או עצירת השתן – עד לברור אצל אורולוג.
3. מצב לאחר ניתוח כולל השתלת כליה מוצלחת, פציעה בכליה או בשופכן, 3 חודשים לאחר החלמה.
4. חולה דיאליזה, לאישור רופא צלילה בכיר.
5. הריון: **אין לצלול במהלך הריון!** ניתן לחזור צלילה חודש לאחר לידה רגילה וחודשיים לאחר ניתוח קיסרי.

עודף משקל:

עודף משקל עד כדי Morbid Obesity לפי BMI>40

BMI מחושב כך: Weight (kg)/height^2 (m)

עודף משקל מעל 40BMI יועבר לאישור רופא צלילה בכיר, שיתחשב בכושר הגופני (נדרש מבחן מאמץ) ובמחלות רקע או מחלות נלוות להשמנה.

בכל מקרה, יומלץ למועמד לרדת במשקל, הוא יוזהר מפני שימוש בתרופות סימפטומטיות להורדת משקל, ויקבל הנחיות למקדמי בטיחות דקומפרסיה בעת צלילה.

מערכת אנדוקרינית:

פסילה תמידית:

1. הפרעה אנדוקרינית המחייבת טיפול ואינה ניתנת לאיזון.
2. סוכרת המחייבת טיפול תרופתי.
3. ניתן לאשר חולה סוכרתי אם התקיימו התנאים הבאים כולם:
   א. לחולה אין נזק end-organ משמעותי.
   ב. החולה מאוזן היטב זה ששה חודשים לפחות כולל היעדר אירועים של היפוגליקמיה סימפטומטית.
   ג. סוכרת לא מאוזנת מוגדרת כסוכרת שבה ערכי הסוכר וההמוגלובין המסוכרר HbA1C גבוהים מהרצוי לאורך זמן ו/או היא מלווה ירידות דרסטיות ברמת הסוכר ("היפוגליקמיה").
   ד. החולה יציב מנטלית ופסיכולוגית ולדעת הרופא המטפל (בכתב) מסוגל להתמודד עם הדרישות המיוחדות שיוטלו עליו כצולל.
   ה. החולה עובר קורס במסגרת מיוחדת לחולי סוכרת והוא צולל בהתאם לתנאים שמנה קורס הצלילה לחולי סוכרת.
   ו. בצולל מוסמך, לאחר הערכה של רופא צלילה או רופא הרשות, בהתאם לטופס הערכה המופיע בנספח להלן.

<u>מחלות מפרקים וקולגן:</u>

<u>פסילה תמידית:</u>

1. מחלת מפרקים כרונית עם כאבים ו/או עיוות המפריעים משמעותית לתפקוד.
2. מחלת קולגן – לאישור רופא צלילה בכיר או רופא הרשות.

<u>מערכת הדם והלימפה:</u>

<u>פסילה תמידית:</u>

1. אנמיה סימפטומטית שאינה ניתנת לתיקון קבוע.
2. מחלת דמם עם דימומים משמעותיים קלינית.
3. מחלות prothromobosis רק לאחר יעוץ המטולוגי.
4. טחול מוגדל יותר מ- 5 ס"מ מתחת לקשת הצלעות.

<u>פסילה זמנית:</u>

1. מחלות ממאירות של מערכת הדם והלימפה – לאישור רופא בכיר או רופא הרשות בהתאם למצב הקליני.
2. אנמיה סימפטומטית – עד לתיקון.

<u>הערה:</u> שימוש בנוגדי קרישה anticoagulants או נוגדי הצמתת טסיות אינו פוסל אך על רופא הצלילה לבדוק האם סיבת הטיפול אינה פוסלת.

<u>הפה והשיניים:</u>

1. מצב המונע החזקה תקינה של ווסת הצלילה בפה – יעוץ רופא צלילה בכיר והמדריך הראשי של הרשות (מסכת פנים שלמה ובקבוק פוני עם מסכה נוספת).
2. מצב לאחר השתלת שן או עקירת שן או טיפול כירורגי אחר – הפסקת צלילה לארבעה שבועות ועד החלמה תפקודית מלאה.

אף ומערות האף:

פסילה זמנית:

1. סינוסיטיס או ריניטיס חריפה עד להחלמה מלאה.
2. ניתוח באף או במערות האף עד להחלמה מלאה.

הפרעה משמעותית באוורור האוזן התיכונה או מערות האף – עד לתיקון הבעיה.

אוזניים:

פסילה תמידית:

1. דלקת כרונית של האוזן התיכונה.
2. הפרעה במעבר האוויר דרך תעלת האוזן החיצונית, שאינה ניתנת לתיקון.
3. מצב לאחר ניתוח באוזן:
   א. mastoidectomy למעט simple mastoidectomy עם אוורור תקין של האוזן.
   ב. Tympanoplasty פרט ל- Type I עם תופית תקינה וניידת.
   ג. Stapedectomy לאישור רופא אף אוזן וגרון ורופא צלילה בכיר.
4. פיסטולה של הלבירינט גם לאחר החלמה.
5. ירידה **חד צדדית** בסף השמיעה מתחת לגבולות כדלהלן:

תדירות: ב- Hz	500	1000	2000	3000	4000
סף ב- dB	30	30	30	45	60

פסילה זמנית:

1. דלקת חריפה באוזן חיצונית, תיכונה או פנימית.
2. חסימה של מעבר אוויר באוזן החיצונית או התיכונה, עד לתיקון.
3. ניתוח באוזן (כזה המאפשר צלילה), עד לאחר החלמה ואישור רופא אא"ג.
4. כל פגיעה ווסטיבולרית סימפטומטית.

הערות:

1. חירשות מוחלטת באוזן אחת – לאישור רופא צלילה בכיר או רופא הרשות. בכל מקרה –מוגבל לצלילה עד 15 מטר באוויר, או שווה ערך חנקן בניטרוקס, ובכל מקרה ללא דקומפרסיה.
2. חירשות מוחלטת בשתי האוזניים – כשיר לצלילה עם בן זוג שומע או לפחות צולל אחד שומע לכל שני צוללים חרשים.

אישור כשירות רפואית לצלילה ספורטיבית ע"י רופא צלילה / רופא צלילה בכיר

גרסת 2025

לכבוד:

שם: _____ ת.ז. _____ שנת לידה _____

כתובת: _____

טל. נייד: _____ דוא"ל: _____

הנך כשיר.ה ללא הגבלות:

- ☐ לצלילת הכרות (intro dive)
- ☐ לקורס צלילה ספורטיבית
- ☐ לקורס צלילה טכנית
- ☐ לקורס דייב מאסטר
- ☐ לצלילה ספורטיבית
- ☐ להמשך צלילה אחרי גיל 45
- ☐ לחזור לצלילה לאחר פסילה עקב מחלה או תאונת צלילה
- ☐ ל _____

הנך כשיר.ה בהגבלות הבאות:

- ☐ לצלילה עד עומק _____ מטר.
- ☐ לקורס שיתבצע במרכז צלילה המוכרת להדרכת בעלי מוגבלויות.
- ☐ עליך לצלול במסגרת מרכז צלילה בלבד.
- ☐ עליך לחשוף מצבך הרפואי בפני המדריך ובן.ת זוגך לצלילה.
- ☐ עליך לצלול עם צולל מלווה המודע למצבך הרפואי בעל הכשרה מתאימה ואשר הודרך.ה בהתאם, רוצה ומסוגל.ת לסייע לך בשעת הצורך.
- ☐ עליך להפסיק מיידית לצלול ולקבל אישור מחודש מרופא צלילה / בכיר בגין כל החמרה מהותית במצבך הרפואי.

☐ **צוללת.ת - עליך לחתום על ההצהרה הבאה**: הריני מאשר.ת בזאת, כי רופא הצלילה הסביר לי וכי אני הבנתי את הסיכונים האישיים שלי בצלילה והסכמתי לקבלם עלי. אני מתחייב.ת להפסיק מיידית לצלול ולפנות לרופא צלילה / רופא צלילה בכיר בגין כל החמרה מהותית במצבי הרפואי הרלוונטי לאישור זה.

חתימת המועמד.ת /הצולל.ת: _____ **תאריך** _____

☐ אינך כשיר.ה רפואית לצלילה עד: _____

☐ **אינך כשיר.ה רפואית לצלילה באורח תמידי.**

שם הרופא: _____ מ.ר. _____ מס. נייד: _____

דוא"ל: _____

תאריך _____

חתימה וחותמת רופא צלילה _____